下载

# 健康体检报告

PHYSICAL CHECKUP REPORT

**体检机构：** 北京酒仙桥分院

优健康

您身边的体检管家！

APP下载

微信公众号

张利顺 先生

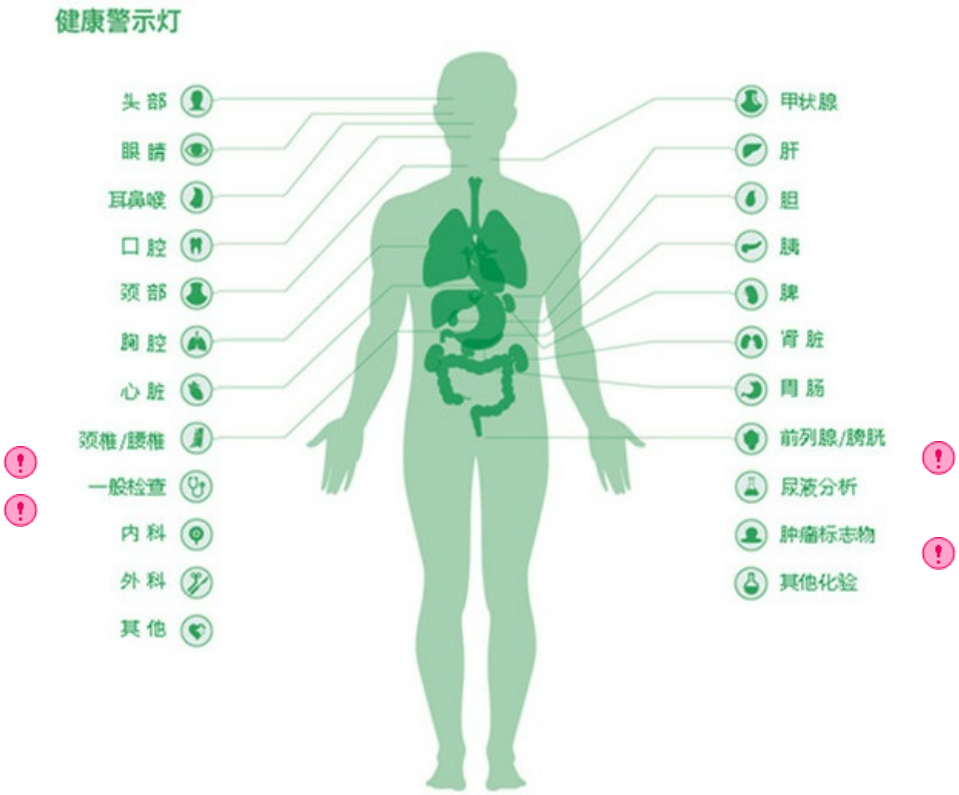
| | |
|---|---|
| 单位名称： | 北京华品博睿网络技术有限公司北京入职自费2018 |
| 身份证： | 220381199104111132 |
| 年龄： | 27 |
| 体检号： | W81703572 |
| 密码： | 215426 |
| 体检时间： | 2018-7-22 8:34:46 |

## 报告阅读说明：

1 您好，欢迎您选择美年大健康体检！美年大健康为您提供健康管理、健康体检、临床检验、特色诊疗、中医养生等全方位的医疗健康服务。

2 医学科技发展至今，现有的医疗技术手段，对于疾病的筛查仍具有局限性和时效性，本次体检由于所选项目受限，会无法发现某些潜在疾病；体检后未发现异常的项目，并不说明就没有潜在疾病，如果有疾病症状出现，请立即就医。

3 本报告书仅对受检者本次所检结果负责;警示部位请您关注，示意图仅供参考。特别说明：对于结论为详见纸质报告的检测项目异常信息及国家规定的单独出报告的检测项目异常信息不纳入健康警示灯及主要阳性结果及建议中。




## 主要阳性结果及异常情况

尊敬的客人：您好！
美年大健康欢迎您的光临,感谢您的信任和支持！
现将您的体检结果呈上,希望能为您的健康管理提供参考！

***** 本体检报告的建议以本页"主要阳性结果及建议"为准，"异常指标解读"中的"指导"为科普性质的泛解，对体检者无指导意义！*****

★ 一般检查1:
体重指数:25.60 超重
1、超重是高血压、冠心病等疾病的危险因素之一；
2、坚持低盐、低脂、低糖膳食，多吃粗粮、蔬菜及水果；
3、早餐吃饱、午餐吃好、晚餐吃少，避免烟酒；
4、如身体状况允许，可选择快走、太极拳等有氧运动，3-5次/周，30-40分钟/次，运动强度以微出汗为标准，否则可选择适量有氧运动，以控制体重。

血压:119/76mmHg

★ 内科检查结果:
心率:心动过速104次/分
1、多见于剧烈运动、紧张、情绪激动、发热、甲亢、心脏疾患等；
2、建议安静状态下观察心率、若持续大于100次/分、或伴有症状，及时专科诊治。

★ 尿白细胞(+-) 镜检：正常：建议定期复查。

★ 血清谷丙转氨酶 增高:
1、可见于劳累、剧烈运动、饮酒、药物性肝损害、脂肪肝、病毒性肝炎等；
2、注意休息,避免劳累；
3、建议4-6周复查, 如持续升高请专科诊治。

体检结果说明:
1.此报告仅作为健康保健之用,不做任何证明依据。
2.检验结果只对本次送检标本负责。
3.如需要咨询体检报告,请致电400-617-7999,我们的医学专家将为您解答。
4.请关注北京美年大健康官方微博并@美年大健康北京。
官方微博：http://e.weibo.com/2636629673/profile

# 异常指标解读

## 体重指数偏高

结果：25.60　　范围:18.5-23.9

**【医学解释】**

医学解释：BMI指数（即身体质量指数，简称体质指数又称体重指数，英文为Body Mass Index，简称BMI），是用体重公斤数除以身高米数平方得出的数字，是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。主要用于统计用途，当我们需要比较及分析一个人的体重对于不同高度的人所带来的健康影响时，BMI值是一个中立而可靠的指标。体重指数24-27.9为超重；大于或等于28为肥胖。

**【常见原因及后果】**

BMI是世界公认的一种评定肥胖程度的分级方法，世界卫生组织(WHO)也以BMI来对肥胖或超重进行定义。体重指数增高，冠心病和脑卒中发病率也会随之上升，超重和肥胖是冠心病和脑卒中发病的独立危险因素。体重指数每增加2，冠心病、脑卒中、缺血性脑卒中的相对危险分别增加15.4%、6.1%和18.8%。 一旦体重指数达到或超过24时，患高血压、糖尿病、冠心病和血脂异常等严重危害健康的疾病的概率会显著增加。

**【建议】**

体重控制方案可使用4种疗法：饮食和营养咨询，行为治疗，药物和外科手术，正规医院专科治疗。

## 心动过速

**【医学解释】**

正常人心跳是规律和整齐的，安静时一般心跳次数是60～100次/分的范围内。随着年龄的增长，心跳逐渐减慢，老年人的心跳次数一般偏慢。 心跳速度过快，成人每分钟心率100~140次，一般不超过150次称心动过速。 心动过速分生理性、病理性两种，病理性心动过速又可分为窦性心动过速和阵发性室上性心动过速两种。

**【常见原因及后果】**

生理因素：其发生常与交感神经兴奋及迷走神经张力降低有关，这是最常见的一种心动过速，可由多种原因引起，如正常人体力劳动或剧烈运动、情绪激动、饱餐、饮浓茶、咖啡；吸烟、饮酒等可使交感神经兴奋，心跳加快。生理因素所致的窦性心动过速常为一过性，持续时间较短。 病理因素：①心力衰竭尤其心力衰竭的早期；②甲状腺功能亢进；③急性心肌梗死；④休克；⑤急性心肌炎；⑥其他器质性心脏病；⑦其他，如贫血、发热、感染、缺氧、自主神经功能紊乱等；⑧药物因素。

**【建议】**

生理性心动过速可通过改变不良的生活习惯，心态平和，加强体质锻炼，增强植物神经自主调节能力，使心率恢复正常。病理性疾病者，主要针对病因治疗。正规医院专科诊治。

## 尿白细胞 弱阳性

结果：+-　　范围:阴性

**【医学解释】**

利用中性粒细胞特有的酯酶能水解试剂中含色原的酯类，释放出色原与重氮盐形成呈色的缩合物。由于淋巴细胞不含酯酶，故严格讲仅检测尿中的中性粒细胞。

**【常见原因及后果】**

尿白细胞阳性：见于各种泌尿系统感染、前列腺炎等。

**【建议】**

尿白细胞阳性，若尿镜检白细胞也增高，建议去医院进一步检查，查明原因。

## 血清谷丙转氨酶 增高

结果：63 U/L　　范围:0-40 U/L

【医学解释】

丙氨酸氨基转移酶(ALT)俗称谷丙转氨酶（GPT），广泛存在于身体组织细胞内，以肝细胞内含量最多，只要有1%的肝细胞损伤，即可使血清中酶活性增高1倍。因此，ALT是最敏感的肝功能检测指标之一，任何原因引起肝细胞损伤，均可导致ALT增高。

【常见原因及后果】

ALT检测主要用于了解肝功能是否有损伤，增高见于：①肝胆系统疾病：急、慢性肝炎，中毒性肝炎，脂肪肝，胆石症，胆囊炎等。 ②心血管疾病：心肌梗死，心肌炎，充血性心力衰竭伴肝肿大。 ③骨骼疾病：多发性肌炎，肌营养不良等； ④药物中毒性肝炎：如服用异烟肼、利福平、氯丙嗪、甲巯咪唑等。

【建议】

剧烈运动或重体力劳动可引起ALT升高，建议充分休息3天后复查，如果仍然升高，请尽早去医院，查明升高原因。

【一般检查1】 医生：陈渌

| 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 |
|---|---|---|---|
| 身高 | 170 | Cm | |
| 体重 | 74 | kg | |
| 体重指数(18.5-23.9) | 25.60 | | |
| 理想体重(kg) | 63.00 | | |
| 收缩压 | 119 | mmHg | |
| 舒张压 | 76 | mmHg | |
| 小结 | 体重指数:25.60<br>血压:119/76mmHg | | |

【内科检查】 医生：王东静

| 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 |
|---|---|---|---|
| 既往史 | 无 | | |
| 心率 | 心动过速104次/分 | 次/分 | |
| 心律 | 整齐 | | |
| 心界 | 不大 | | |
| 心音 | 正常 | | |
| 心脏杂音 | 未闻及病理性杂音 | | |
| 胸廓 | 未见异常 | | |
| 肺部听诊 | 双肺呼吸音正常，无干湿罗音 | | |
| 腹壁 | 未见异常 | | |
| 肝 | 未触及 | | |
| 胆 | 无压痛点 | | |
| 脾 | 未触及 | | |
| 肾 | 肾区无叩痛 | | |
| 肠鸣音 | 未见异常 | | |
| 神经系统 | 生理反射存在，病理反射未引出 | | |
| 其他 | | | |
| 小结 | 心率:心动过速104次/分 | | |

【静态心电图】 医生：白丽华

| 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 |
|---|---|---|---|
| 小结 | 窦性心律<br>正常心电图 | | |

【胸部正位片（放射科）】 医生：米玉俊

| 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 | | | |
| 检查结果 | 胸部正位片（放射科）未发现明显异常 | | |

**【空腹血糖（Glu）】** **医生： 苏新/董敏**

| 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血糖（空腹） | 5.03 | mmol/L | 3.89-6.11 |

**【尿常规】** **医生：项丹/董敏**

| 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酸碱度 | 6.0 | | 5-8 |
| 尿葡萄糖 | 阴性 | | 阴性 |
| 尿白细胞 | 弱阳性 | | 阴性 |
| 亚硝酸盐 | 阴性 | | 阴性 |
| 尿胆原 | 阴性 | | 阴性 |
| 尿蛋白质 | 阴性 | | 阴性 |
| 尿隐血 | 阴性 | | 阴性 |
| 尿比重 | 1.025 | | 1.010-1.030 |
| 尿酮体 | 阴性 | | 阴性 |
| 尿胆红素 | 阴性 | | 阴性 |
| 尿透明度 | 透明 | | 透明 |
| 尿液颜色 | 黄色 | | 淡黄色-黄色 |
| 尿白细胞镜检 | 未见 | /HP | 0-5 |
| 尿红细胞镜检 | 未见 | /HP | 0-3 |
| 尿液管型 | 未见 | /LP | |
| 尿结晶 | 未见 | | |

**【心肌酶4项（CK LDH HBDH CK-MB）】** **医生： 苏新/董敏**

| 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 羟基丁酸脱氢酶 | 144 | U/L | 72-182 |
| 肌酸激酶 | 97 | U/L | 24-194 |
| 血清乳酸脱氢酶 | 183 | U/L | 109-245 |
| 肌酸激酶同功酶 | 15 | U/L | 0-25 |

**【血常规】** **医生：项丹**

| 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 白细胞计数(血) | 7.6 | 10^9/L | 4.0-10 |
| 红细胞计数 | 5.19 | 10^12/L | 4.0-5.5 |
| 血红蛋白 | 160 | g/L | 120-160 |
| 红细胞压积 | 46.7 | L/L | 40-49 |
| 平均红细胞体积 | 90.0 | fl | 80.00-99.00 |
| 平均红细胞血红蛋白量 | 31.0 | pg | 26.50-33.50 |
| 平均红细胞血红蛋白浓度 | 345 | g/L | 320-360 |
| 血小板计数 | 208 | 10^9/L | 100-300 |
| 淋巴细胞百分率 | 33.4 | % | 20.00-50.00 |
| 中值细胞百分率 | 6.0 | % | 1.00-15.00 |
| 中性粒细胞百分率 | 60.6 | % | 40.00-70.00 |
| 淋巴细胞绝对值 | 2.5 | 10^9/L | 0.60-4.10 |
| 中值细胞绝对值 | 0.5 | 10^9/L | 0.10-1.80 |
| 中性粒细胞绝对值 | 4.6 | 10^9/L | 2.00-7.80 |
| 红细胞分布宽度—变异系数 | 12.5 | fL | 10-15 |
| 血小板分布宽度 | 12.8 | % | 10.00-18.00 |
| 平均血小板体积 | 10.1 | fl | 7.00-11.00 |
| 大血小板比率 | 0.259 | % | 0.13-0.43 |

**【血清谷丙转氨酶(ALT)】** **医生： 苏新/董敏**

| 检查项目名称 | 结果 | 单位 | 正常范围值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血清谷丙转氨酶 | 63 ↑(**) | U/L | 0-40 |